

Infecciones respiratorias bajas recomendaciones de Oseltamir 2014

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO CON ANTIVIRALES

En todos los casos, pero fundamentalmente en población ambulatoria, es importante que el pediatra utilice su criterio clínico frente a situaciones individuales (tanto en pacientes con factores de riesgo o no) que así lo requieran. Los pacientes que presenten ETI con persistencia de fiebre y que puedan generar dudas sobre el uso de antivirales, quedarán a consideración de la evaluación clínica y la decisión final será del pediatra que interviene en la consulta.

Es altamente recomendable que se insista en llegar al diagnóstico etiológico viral con los métodos disponibles para evitar tratamientos innecesarios, aumentando el riesgo de eventos adversos y potencial desarrollo de resistencia a los antivirales.

El Oseltamivir continua siendo la droga de elección para el tratamiento de las infecciones por influenza. Se encuentra disponible en cápsulas o en suspensión oral. Si la formulación líquida no estuviera disponible puede utilizarse la cápsula para preparar la solución de acuerdo a las recomendaciones de ANMAT

Si bien en revisiones realizadas no se observó una eficacia para prevenir las complicaciones o las internaciones por influenza los pacientes con factores de riesgo o cuadro clínico progresivo podrían beneficiarse con la indicación temprana. La respuesta es mayor cuando se inicia un tratamiento dentro de las primeras 48 hs del inicio de los síntomas, pero en los niños y adolescentes con cuadros moderados progresivos o graves, puede ser indicado más tardíamente.

En los pacientes **internados**:

- Se recomienda tratamiento antiviral en pacientes con **infección respiratoria grave** que requieran terapia intensiva y/o ARM.
- Se recomienda tratamiento antiviral a los pacientes con cuadros moderados o con factores de riesgo y con **IFI positiva** para **Influenza** hasta tener el resultado de PCR-real time.

En niños con cuadros progresivos se debe priorizar el tratamiento al diagnóstico virológico, **si la IFI es negativa o no se puede realizar, se debe completar el tratamiento.**

Si se el resultado del estudio virológico es positivo para otro virus respiratorio, se evaluará suspender el tratamiento antiviral de acuerdo al cuadro clínico del niño.

En los pacientes **ambulatorios**:

- Se recomienda tratamiento antiviral en niños y adolescentes **con factores de riesgo y con infección respiratoria baja** independientemente de otros tratamientos, fundamentalmente en momentos de circulación predominante del virus influenza

Los **factores de riesgo** para influenza A son:

Grupo 1: Enfermedades respiratorias:

- a) Asma moderado y grave
- b) Enfermedad respiratoria crónica (displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística, malformaciones pulmonares, traqueostomizados, Enfermedad Pulmonar Crónica Post infecciosa (EPCPI).
- c) Enfermedad pulmonar restrictiva (enfermedad pulmonar intersticial, neuromusculares, malformaciones de caja torácica y escoliosis severa)

Grupo 2: Enfermedades cardíacas:

- a) Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía
- b) Cardiopatías congénitas

Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no hemato-oncológica).

- a) Infección por VIH
- b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)
- c) Inmunodeficiencia congénita.
- d) Asplenia funcional o anatómica
- e) Desnutrición grave

Grupo 4: Pacientes Oncohematológicos y trasplantados

- a) Tumor de órgano sólido en tratamiento
- b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa
- c) Trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético

Grupo 5: Otros

- a) Obesos con índice de masa corporal [IMC] mayor a 40
- b) Diabéticos
- c) Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses
- d) Retraso madurativo grave en menores de 18 años de vida
- e) Síndromes genéticos y malformaciones congénitas graves
- f) Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.
- g) Convivientes de enfermos oncohematológicos
- h) Convivientes de prematuros menores de 1500 g.

Oseltamivir: dosis recomendadas en relación a edad y peso

Oseltamivir	
Tratamiento en Niños ≥12 meses o mayores	
Peso	Dosis recomendada por 5 días
<15 kg	30 mg c/12hs
15–23 kg	45 mg c/12hs
24–40 kg	60 mg c/12hs
>40 kg	75mg c/12 hs
Oseltamivir	
Tratamiento en niños <1 año*	
Edad	Dosis recomendada por 5 días**
<3 meses	12 mg c/12 hs
3-5 meses	20 mg c/12 hs
6-11meses	25 mg c/12 hs

*Aprobado por la FDA a fines de 2012 a partir de las 2 semanas de vida

<http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm333205.htm>

** 0 – 8 meses: 3 mg/kg. 9 – 11 meses: 3,5 mg/kg. Dos veces por día

Los infantes pretérmino podrían tener disminuido el clearance de la droga debido a inmadurez renal, por lo que las dosis recomendadas para niños de término serían altas y se recomienda:

Niños pretérmino <38 semanas: 1mg/kg dosis VO dos veces al día

Niños pretermino entre 38 y 40 semanas: 1,5 mg/kg/dosis VO dos veces al día

En paciente con Insuficiencia renal debe realizarse ajuste según clearance de creatinina

Formas farmacéuticas:

- Cápsulas de 30-45-75 mg
- Polvo suspensión de 12mg por ml

Zanamivir:

Niños mayores de 7 años: 10 mg (dos inhalaciones de 5 mg) cada 12 hs por 5 días.

Recomendaciones sobre el uso de oseltamivir en pediatría en niños que no pueden tragar cápsulas.

Se requiere

1. Una cápsula de Oseltamivir de 30 o 45 mg, según prescripción médica
2. Un pequeño recipiente de vidrio u acero inoxidable y una espátula pequeña de plástico duro o cucharita
3. Un alimento de gusto agradable que el niño acepte, preferentemente de consistencia cremosa tipo flancito, en pequeña cantidad, para mezclar con el medicamento y enmascarar su sabor. Evitar jugos de frutas cítricas, miel y líquidos calientes.

Procedimiento

1. En una zona previamente limpia, con las manos bien lavadas con abundante agua y jabón y secas, proceder a retirar una cápsula del blister.
2. Sobre el recipiente dejar caer el contenido de la cápsula. Para ello se debe tomar, con las manos secas, un extremo de la cápsula con cada mano y rotar suavemente tirando hacia fuera para que se separen las dos mitades de la cápsula, que son de distinto color. Verificar que todo el polvillo blanco de su interior se deposite en el fondo del recipiente.

Precaución: manejar el contenido de la cápsula con cuidado ya que el polvillo es irritante para la piel y los ojos.

3. Incorporar una o más cucharaditas del alimento de sabor agradable, mezclar cuidadosamente y dársela al niño, asegurándose de que todo el polvillo haya sido ingerido. También puede comenzarse con postre solo y luego intercalar la mezcla, para su mejor aceptación.

Nota: Si se prepara con 75 mg, se puede tomar dicha cápsula y siguiendo las indicaciones en cuanto a procedimiento del ANMAT, diluir su contenido en 5 cm³ de agua (quedan 15 mg por cm³) y calcular la dosis necesaria para nuestro paciente.

Eventos adversos

La frecuencia de eventos adversos fue muy baja. Los más frecuentemente informados en la población general con oseltamivir fueron náuseas y vómitos. Otros efectos como diarrea se presentaron en proporción similar a los que no fueron tratados con inhibidores de neuraminidasa. En niños con factores de riesgo tratados con oseltamivir o zanamivir, no se registraron efectos significativos ni eventos graves relacionados a su indicación. Existe poca información sobre la seguridad en lactantes pequeños por lo que se recomienda el monitoreo cercano cuando se indica oseltamivir en este grupo.

Bibliografía recomendada

- Ministerio de Salud de la Nación. Recomendaciones para la vigilancia, prevención y atención de las Infecciones Respiratorias Agudas en Argentina. Actualización Marzo de 2014
- Ministerio de Salud de la Nación. Vigilancia de infecciones respiratorias agudas. Boletín Integrado de Vigilancia SE12 - N208: 14-28.